

Datei: 10_email_ehemann.eml

Von	samir.tunc@example.invalid
An	rentenberater@example.invalid
Datum	Tue, 30 Jun 2026 22:41:00 +0200
Betreff	Therapieslot und Angst vor Kosten

Guten Abend,

Leyla will nicht, dass wir alles verkaufen für ein Medikament, das vielleicht nicht wirkt. Gleichzeitig sagt die Klinik, dass wir das Fenster nicht verpassen dürfen. Ich brauche eine klare Liste, was das Gericht vor dem 18. Juli wirklich sehen muss.

Bitte sagen Sie auch, welche Unterlagen von der Schule wichtig sind. Leyla versucht noch Korrekturen zu machen, aber sie kann kaum 20 Minuten lesen.

Viele Grüße

Samir Tunc

Datei: 04_kostenplan_apotheke.csv

position	menge	kosten_eur	notiz
Neravexor Dosis 1	1	480000	Import und Zubereitung
Stationäre Überwachung Dosis 1	1	12500	3 Tage
Neravexor Dosis 2	1	480000	8 Wochen später
Stationäre Überwachung Dosis 2	1	12500	3 Tage
Begleitdiagnostik	2	7800	MRT Labor Liquor

Mandatsnotiz Eilverfahren Off-Label-Use

1. Mandantin

Mandantin ist Leyla Tunc, geboren am 16.11.1991, Grundschullehrerin aus Mainz. Diagnose: progrediente Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil, Schübe seit 2024, deutliche Gang- und Sehstörungen, kognitive Erschöpfung. Krankenkasse: RheinMain BKK.

2. Beantragte Behandlung

Universitätsmedizin Mainz beantragt Neravexor, ein monoklonales Antikörperpräparat, zugelassen für eine andere seltene neuroimmunologische Indikation. Für Leylas Erkrankung besteht keine deutsche Zulassung. Klinik schlägt zwei Dosen im Abstand von acht Wochen vor. Kosten laut Klinikapotheke: 480.000 EUR je Dosis einschließlich Zubereitung und stationärer Überwachung.

3. Verfahren

Antrag der Klinik 07.06.2026. MD-Gutachten 20.06.2026. Ablehnungsbescheid 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Geplanter stationärer Slot 18.07.2026. Widerspruch und Eilantrag müssen parallel vorbereitet werden.

4. Rentenberaterliche Perspektive

Kurzfristig Krankenversicherungsanspruch und Eilrechtsschutz. Parallel: Krankengeld, Reha, mögliche Erwerbsminderung, Schwerbehindertenverfahren und dienstrechtliche Fragen nur koordinierend. Die Akte darf medizinische Hoffnung nicht mit rechtlicher Erfolgsaussicht verwechseln; die drei Off-Label-Kriterien müssen materialgestützt abgearbeitet werden.

Klinikantrag Universitätsmedizin Mainz

1. Medizinischer Stand

Die Patientin leidet an einer rasch progredienten Autoimmun-Enzephalomyelitis mit seltenem Antikörperprofil. Standardtherapien mit hochdosierten Steroiden, Plasmapherese, Rituximab und Cyclophosphamid führten nur zu vorübergehender Stabilisierung. Seit Mai 2026 neue Herde im MRT und Verschlechterung der Gehstrecke auf unter 200 Meter.

2. Behandlungsziel

Neravexor soll die Krankheitsprogression stoppen oder verlangsamen, Schubaktivität senken und den Verlust selbständiger Gehfähigkeit verhindern. Eine Heilung wird nicht versprochen. Die Klinik hält eine palliative und stabilisierende Wirkung für realistisch.

3. Evidenzmaterial

Die Klinik legt eine Phase-II-Studie zur verwandten Antikörpergruppe, zwei Fallserien, ein Registersignal und eine Stellungnahme des europäischen Referenzzentrums vor. Eine Phase-III-Studie für exakt diese Indikation existiert nicht. Die Klinik argumentiert mit Seltenheit, Pathomechanismus und fehlender Alternative.

MD-Gutachten, Auszug

1. Ergebnis

Der MD empfiehlt Ablehnung der Kostenübernahme. Es liege ein Off-Label-Use außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung vor. Eine Empfehlung in der Arzneimittel-Richtlinie sei nicht ersichtlich. Für die konkrete Indikation fehle eine hochwertige Studie mit klinisch relevantem Nutzen.

2. Anerkannte Punkte

Der MD erkennt die Schwere der Erkrankung und die erhebliche Teilhabebeeinträchtigung an. Standardtherapien seien weitgehend ausgeschöpft. Gleichwohl sei der Nutzen von Neravexor für diese Indikation nicht hinreichend belegt.

3. Angriffspunkte

Das Gutachten setzt sich nur knapp mit der Registerauswertung und der Stellungnahme des Referenzzentrums auseinander. Es prüft nicht ausdrücklich, ob eine notstandsähnliche Situation nach Paragraph 2 Abs. 1a SGB V in Betracht kommt. Für den Eilantrag braucht es eine ärztliche Zusatzstellungnahme zu Prognose ohne Behandlung.

Arbeitsnotiz Studienlage

1. Material der Klinik

Die Klinik legt keine Phase-III-Studie für exakt Leylas Indikation vor. Vorhanden sind eine kleine kontrollierte Phase-II-Studie bei verwandter Erkrankung, zwei Fallserien mit insgesamt 19 Patienten, ein Registersignal und ein Expertenbrief. Das Material ist medizinisch ernst zu nehmen, rechtlich aber angreifbar.

2. Rechtliche Sortierung

Für den allgemeinen Off-Label-Use werden typischerweise schwere Erkrankung, fehlende Therapiealternative und begründete Erfolgsaussicht verlangt. Bei notstandsähnlicher Lage nach Paragraph 2 Abs. 1a SGB V kann die Prüfung anders akzentuiert sein, bleibt aber nicht evidenzfrei. Der Schriftsatz muss beides trennen.

3. Benötigte Ergänzung

Die Klinik soll bis 06.07.2026 beantworten: Wie schnell droht irreversible Verschlechterung? Welche Standardtherapie ist konkret ausgeschöpft? Welche objektiven Marker sprechen für Neravexor? Welches Risiko entsteht durch Abwarten bis Hauptsacheentscheidung?

Ablehnungsbescheid RheinMain BKK

1. Entscheidung

Die Kostenübernahme für Neravexor wird abgelehnt. Die beantragte Behandlung sei nicht Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung für die vorliegende Indikation und erfülle nach MD-Bewertung nicht die Voraussetzungen einer ausnahmsweisen Leistung.

2. Begründung

Die Kasse verweist auf fehlende Zulassung, fehlende G-BA-Empfehlung, nicht ausreichende Evidenz und Wirtschaftlichkeit. Sie bietet eine erneute Beratung zu symptomatischer Therapie, Physiotherapie und Rehabilitation an.

3. Frist

Bescheid vom 24.06.2026, Zugang 26.06.2026. Widerspruchsfrist 26.07.2026. Wegen Behandlungsslot am 18.07.2026 ist Eilrechtsschutz vorher erforderlich.

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Übernahme der Kosten für die Behandlung mit Neravexor gemäß Antrag der Universitätsmedizin Mainz.

2. Begründung

Die Mandantin leidet an einer schwerwiegenden, rasch progredienten Erkrankung. Standardtherapien wurden ausgeschöpft oder sind medizinisch nicht mehr erfolgversprechend. Die Klinik legt eine pathophysiologisch begründete und durch Studien- sowie Registermaterial gestützte Erfolgsaussicht dar. Die Kasse und der MD haben die notstandsähnliche Lage und die konkrete Prognose ohne Behandlung nicht ausreichend gewürdigt.

3. Nachreichung

Eine ergänzende fachärztliche Stellungnahme zur Dringlichkeit, Alternativlosigkeit und Nutzenwahrscheinlichkeit wird bis 08.07.2026 nachgereicht.

Eilantrag Sozialgericht, Arbeitsfassung

1. Antrag

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, der Antragstellerin vorläufig die Kostenübernahme für die Behandlung mit Neravexor entsprechend dem Therapieplan der Universitätsmedizin Mainz zu gewähren.

2. Anordnungsanspruch

Der Anspruch wird auf die außergewöhnliche Schwere, die fehlende Standardalternative, die fachärztlich begründete Erfolgsaussicht und die besondere Dringlichkeit gestützt. Der Schriftsatz muss offenlegen, dass die Evidenz nicht dem Regelfall entspricht, und erklären, warum dies bei der Seltenheit und Progression nicht zur Ablehnung führen darf.

3. Anordnungsgrund

Der Therapieslot am 18.07.2026 ist reserviert. Nach Klinikangabe drohen bei weiterem Schub irreversible Gang- und Sehverschlechterungen. Abwarten bis zur Hauptsacheentscheidung würde den möglichen Nutzen der Behandlung entwerten.

Folgeprüfung Krankengeld, Reha und Rente

1. Leistungsübersicht

Leyla Tunc ist seit 03.05.2026 arbeitsunfähig. Entgeltfortzahlung läuft voraussichtlich bis 14.06.2026, danach Krankengeld. Schwerbehindertenantrag wurde noch nicht gestellt. Reha war wegen instabiler Erkrankung zurückgestellt.

2. Rentenberaterliche Folgearbeit

Krankengeldfrist, Reha-Antrag, Schwerbehindertenrecht und Erwerbsminderungsrente müssen in einem Fristenblatt geführt werden. Der Off-Label-Eilantrag hat Vorrang, aber die medizinischen Unterlagen sollen so abgelegt werden, dass sie später für Reha, GdB und Erwerbsminderung wiederverwendbar sind.